

FACULTE DE MEDECINE

DEPARTEMENT DE MEDECINE
DR. BOUKERROUCHA Redhouane

Rétrécissement mitral

Cours destinée aux externes.

Module Cardiologie année 2025 -2026.

Rétrécissement mitral

[16, 24-34, 136, 139]

GENERALITES

Le rétrécissement mitral est défini par une gêne au remplissage ventriculaire gauche secondaire à un obstacle sur l'orifice mitral.

ETIOLOGIES

Le rétrécissement mitral est pour l'essentiel une valvulopathie acquise, Le rhumatisme articulaire est la cause quasi exclusive (80 à 90 % des cas), avec prédilection pour le sexe féminin (1 homme pour 3 à 4 femmes) ;

Le rétrécissement se développe entre 5 à 20 ans après l'atteinte rhumatismale initiale; la maladie se déclare souvent entre 30 à 40 ans d'âge ;

C'est la plus fréquente des valvulopathies rhumatismales, une lésion sténosante de la valve mitrale est retrouvée dans 65 % des cas (soit pure dans 25 % des cas ou associée à une régurgitation mitrale dans 40 % des cas) ;

Les autres causes sont : Rétrécissement mitral congénital, Syndrome de Lutembacher, Calcifications dégénératives de l'anneau mitral, Endocardite bactériennes avec végétations exubérantes, Maladie carcinoïde cardiaque, Fibrose endomyocardique, Maladies inflammatoires (LED), Polyarthrite rhumatoïde, Mucopolysaccharidose, Traitement par méthylsergide.

ANATOMIE-PATHOLOGIE

A l'état normal, l'orifice mitral a une surface de 4 à 6 cm², en cas de rétrécissement mitral, on note une fusion des commissures, les valves sont altérées de simple épaissement à la calcification massive, l'appareil sous valvulaire est également atteint avec cordages épaissis, raccourcis et fusionnés voire disparaître avec feuillets valvulaires s'insérant directement sur les piliers,

Ainsi, l'atteinte rhumatismale réalise de la simple fusion commissurale à un orifice central en entonnoir rigide ;

L'orifice central est rarement circulaire mais souvent de forme curviligne, sa surface est réduite (Surface mitrale < 2 cm² : sténose modérée, Surface mitrale < 1.5 cm² : sténose moyenne et Surface mitrale < 1 cm² : sténose très serrée) ;

L'oreillette gauche à l'état normale a un volume de 50 à 60 cm³, en cas d'obstacle mitral, l'OG se dilate et sa capacité dépasse les 150 cm³, sa paroi s'amincit et les fibres musculaires sont remplacés par de tissu fibreux, favorisé par la perte du rythme sinusal ;

Les thromboses intra-auriculaires gauches se voit dans 5 à 20 % des cas, parfois la paroi postérieure de l'OG est tapissée de thrombus d'âge différent, parfois il s'agit d'une thrombose massive de l'OG ;

Les cavités droites sont hypertrophiées et dilatées, le ventricule gauche est souvent de petite taille en cas de rétrécissement pur ;

Au niveau du poumon, le retentissement prend différents aspects, le tissu pulmonaire est ferme, lourd, dense, parfois présence de foyer hémorragique et d'infarctus, la muqueuse bronchique est oedématisée, hyperhémie, les veines pulmonaires et les capillaires sont dilatés et épaissies, les artérioles surtout précapillaires ont une lumière réduite par hypertrophie de la

média, les résistances artériolaires pulmonaires s'élèvent, les artères pulmonaires principales se dilatent et s'hypertrophient.

PHYSIO-PATHOLOGIE

Les conséquences du rétrécissement mitral sont multiples :

Conséquences hémodynamiques :

A l'état normal, la surface mitrale en diastole est de 4 à 6 cm², les pressions diastoliques de l'oreillette gauche et du ventricule gauche sont superposables ; au dessous de 2 cm² de surface utile, la pression auriculaire devient supérieure à celle du ventricule gauche pendant la diastole, le gradient de pression trans-mitral est proportionnel au débit sanguin trans-mitral (effort, fièvre, émotion, tachycardie, grossesse, anémie, hyperthyroïdie) et à la surface mitrale ;

La surface mitrale selon formule de Gorlin ($SM \text{ surface mitrale (cm}^2\text{)} = \text{Débit mitral diastolique (ml/s)} / 38 \sqrt{DP}$) ;

Le débit cardiaque de repos tend à diminuer en cas de RM serré, en cas d'effort, le débit cardiaque augmente mais reste insuffisant à la demande ;

La pression capillaire suit passivement l'élévation de la pression auriculaire, selon les patients, l'œdème pulmonaire apparaît si la pression dépasse (25 à 30 mm Hg), quant à la pression artérielle pulmonaire, elle suit la pression capillaire, elle est modérée tant que les résistances vasculaires restent normale (hypertension postcapillaire), lorsque l'obstacle mitral n'est pas levé, les résistances vasculaires s'élèvent, l'hypertension artérielle pulmonaire devient majeur (supérieur ou égale à 40 mm Hg), cette hypertension (post et précapillaire) régresse progressivement à la levée du barrage mitral ;

Le ventricule droit subit les conséquences de cette hypertension pulmonaire, d'abord hypertrophie du VD puis dilatation du VD et insuffisance tricuspide.

Fonction ventriculaire gauche :

Au cours du rétrécissement mitral malgré l'absence de surcharge volumétrique ou barométrique du ventricule gauche, une dysfonction systolique et diastolique est notée, en rapport avec la petite taille du VG (obstacle mitral, réduction de la distensibilité du VG secondaire à la sclérose de l'appareil sous valvulaire) ;

La fraction du VG est légèrement diminuée secondaire aux modifications des conditions de charge, anomalies de la cinétique régionale, l'interaction du ventricule droit dilaté et les séquelles de la myocardite rhumatismale.

Fonction de l'oreillette gauche :

En présence d'un rétrécissement mitral, l'OG se dilate, associée à une diminution du débit trans-mitral et la perte du rythme régulier, on constate une stase sanguine au niveau de l'OG visualisée à l'échographie cardiaque (ETT et ETO), responsable d'accident thromboembolique.

Fonction respiratoire :

Les lésions anatomiques pulmonaires, la cardiomégalie et l'augmentation du volume sanguin intrathoracique sont responsables d'une insuffisance respiratoire restrictif ou mixte, on constate une redistribution sanguine vers les régions apicales et vasoconstriction des bases responsable de l'hypoxémie artérielle.

DIAGNOSTIC DU RETRECISSEMENT MITRAL

Circonstances de découverte :

Le rétrécissement mitral peut rester asymptomatique pendant plusieurs années, parmi les symptômes qui révèlent cette valvulopathie, on décrit :

- La dyspnée d'effort
- Crise d'œdème aigu pulmonaire nocturne
- Les hémoptysies
- Les palpitations
- Angor fonctionnel

L'examen clinique :

Dans les formes évoluées qui deviennent rare, la présence le classique facies mitral (érythrose et cyanose des pommettes et des lèvres) frappe à l'examen clinique du patient, on peut observer chez l'enfant un certain degré de retard staturo-pondéral ;

L'examen clinique recherche un frémissement diastolique à la pointe renforcé par le décubitus latéral gauche, éclat du B1, signe de Harzer témoin d'une hypertrophie du ventricule droit, un soulèvement systolique parasternal gauche témoin de l'hypertrophie dilatation de l'infundibulum pulmonaire.

L'auscultation cardiaque au foyer apexien, retrouve le rythme mitral de Duroziez : éclat de B1 sauf en cas de RM calcifié (B1 atténué ou disparaît), claquement d'ouverture mitrale, roulement diastolique ;

Les signes du retentissement hémodynamique du RM sont : éclat de B2 au foyer pulmonaire (HTAP), souffle systolique xiphoïdien majoré par l'inspiration (en cas d'insuffisance tricuspide), souffle diastolique d'insuffisance pulmonaire (HTAP) ;

Egalement, l'auscultation peut révéler des signes pleuro-pulmonaires (râles crépitants, épanchements pleuraux), des signes de stase périphérique (hépatomégalie, œdèmes).

Les examens paracliniques :

Téléthorax :

Le téléthorax révèle différentes anomalies :

- Allongement de l'arc moyen gauche avec aspect de doubles saillies convexes superposées (tronc de l'artère pulmonaire et l'auricule gauche)
- En cas d'hypertrophie du ventricule droit, l'arc inférieur gauche devient rectiligne avec pointe sus diaphragmatique
- Le bord droit du cœur prend un aspect de double contour inscrit ou superposé
- En incidence oblique antérieure droite, l'oreillette gauche dilatée refoule l'œsophage baryté
- En incidence oblique antérieure gauche permet d'apprécier la dilatation des cavités droites
- Les calcifications mitrales et de l'oreillette gauche sont à rechercher en oblique antérieure droite

- La surcharge pulmonaire se manifeste par une redistribution vasculaire vers les sommets, dilatation des branches de l'artère pulmonaire, opacités floues périhilaires, aspect réticulonodulaire des bases et des petites opacités linéaires horizontales (lignes B de Kerly), aspect de miliaire pulmonaire,
- Des épanchements pulmonaires

Electrocardiogramme:

Les anomalies électrocardiographiques sont fonction de la sévérité du rétrécissement mitral et de son stade évolutif, on peut observer :

- Le patient peut garder un rythme sinusal, associé à des signes d'hypertrophie auriculaire gauche (onde P allongée ≥ 0.12 sec, bifide en D2 et précordiales gauche, diphasique en V1) et de surcharge ventriculaire droite (déviations de l'axe de QRS à droite, inversion du rapport R/S, bloc incomplet droit, parfois inversion de l'onde T en précordiales droites) ;
- L'arythmie complète par fibrillation auriculaire paroxystique puis permanente se voit dans les formes évoluées ;

Phonomécanogramme:

Supplanté par l'échocardiographie, elle se base sur :

- L'allongement de l'intervalle Q-B1 (onde Q de l'ECG-premier bruit)
- Raccourcissement de l'intervalle B2-COM (deuxième bruit-claquement d'ouverture mitrale)
- L'indice de Wells (Q-B1) – (B2-COM) significatif de sténose serrée s'il dépasse 0.01 sec

Echocardiographie Doppler:

L'échographie Doppler cardiaque permet le diagnostic du RM, d'apprécier l'état anatomique de l'appareil mitral, de quantifier le RM et d'apprécier son impact hémodynamique :

- Diagnostic :

Le mode TM montre un épaississement des échos valvulaires, le ralentissement de la pente EF de l'écho de la valve antérieure et le mouvement paradoxal antérieur de la valve postérieure en diastole ;

L'échographie bidimensionnelle montre : une valve antérieure épaissie de cinétique anormale en dôme (remaniement modérée), une valve postérieure de mobilité réduite.

- L'état anatomique :

L'échographie bidimensionnelle qui permet d'apprécier l'état anatomique de l'appareil valvulaire mitral (épaisseur des valves, souplesse, présence de calcifications et leurs localisations).

Plusieurs classifications ont été proposées, basées sur la mobilité, l'épaisseur, les calcifications et le remaniement sous valvulaire ; pour le score de Wilkins [30, 136], chaque paramètre est noté de 1 à 4 points, un total de 4 pour les formes moins sévères et 16 pour les formes avancées incompatible avec une dilation percutanée, la classification de Cormier en trois classes [30].

- Quantification du RM :

Au mode TM, une estimation semi-quantitative de la sévérité du RM est faite par la mesure de la pente EF (vitesse de refermeture protodiastolique de la valve antérieure) ;

Au mode bidimensionnelle (BD), la surface mitrale est mesurée par planimétrie en coupe parasternale transversale (mesure anatomique), de fiabilité correcte en absence de calcifications importantes, d'arythmie rapide ou d'antécédents de commissurotomie ;

Le doppler, permet une mesure physiopathologique, plusieurs méthodes sont utilisées pour la mesure de la surface mitrale:

- le temps de demi-pression (pression half time : PHT, $SM = 220/PHT$), bonne méthode pour mesurer la surface mitrale même en présence d'une IM, mais cette méthode tend à surestimer la surface mitrale en cas d'IA° importante et en cas de troubles de la compliance ventriculaire par élévation de la pression diastolique du VG, elle sous estime la surface mitrale en cas d'ischémie ou d'hypertrophie du VG ;
- Equation de continuité, en absence de régurgitation significative, la surface mitrale égale au volume d'éjection divisé par l'intégrale de la vitesse trans-mitrale ($SM = VES/ITVm$), le VES (mesuré au niveau de la chambre de chasse du VG et en cas d'IA° importante au niveau du VD)
- Mesure de la surface du jet mitral,
- Zone de convergence du flux en amont de l'orifice mitral

Egalement le doppler permet de mesurer le gradient diastolique trans mitral (Doppler continu) ;

Table 5 Assessment of mitral valve anatomy according to the Wilkins score

Grade	Mobility	Thickening	Calcification	Subvalvular Thickening
1	Highly mobile valve with only leaflet tips restricted	Leaflets near normal in thickness (4-5 mm)	A single area of increased echo brightness	Minimal thickening just below the mitral leaflets
2	Leaflet mid and base portions have normal mobility	Midleaflets normal, considerable thickening of margins (5-8 mm)	Scattered areas of brightness confined to leaflet margins	Thickening of chordal structures extending to one-third of the chordal length
3	Valve continues to move forward in diastole, mainly from the base	Thickening extending through the entire leaflet (5-8 mm)	Brightness extending into the mid-portions of the leaflets	Thickening extended to distal third of the chords
4	No or minimal forward movement of the leaflets in diastole	Considerable thickening of all leaflet tissue (>8-10 mm)	Extensive brightness throughout much of the leaflet tissue	Extensive thickening and shortening of all chordal structures extending down to the papillary muscles

The total score is the sum of the four items and ranges between 4 and 16.

Classification du rétrécissement mitral: Score de Wilkins; D' après Helmut Baumgartner, Page 14 [30].

Table 6 Assessment of mitral valve anatomy according to the Cormier score

Echocardiographic group	Mitral valve anatomy
Group 1	Pliable non-calcified anterior mitral leaflet and mild subvalvular disease (i.e. thin chordae ≥ 10 mm long)
Group 2	Pliable non-calcified anterior mitral leaflet and severe subvalvular disease (i.e. thickened chordae < 10 mm long)
Group 3	Calcification of mitral valve of any extent, as assessed by fluoroscopy, whatever the state of subvalvular apparatus

Classification du rétrécissement mitral: Score de Cormier ; D' après Helmut Baumgartner, Page 15 [30].

- Retentissement hémodynamique :

L'échographie Doppler permet d'apprécier la fonction systolique du VG (dimensions, FE, FR, épaisseur de la paroi), mesurer le niveau de la pression artérielle pulmonaire systolique (IT) et la pression pulmonaire diastolique (IP)

D'apprécier la dilatation des cavités droites (VD, OD) et de l'OG, thrombose intra OG ou intra auriculaire, rechercher d'autres lésions valvulaires associées.

Evaluation du RM (une PHT égale à 200 ms correspond à une surface mitrale de 1 cm²)
D'après Ariel Cohen, Page 645-675 [25].

	PHT (ms)	Surface (cm ²)	Gradient moyen (mm Hg) (débit cardiaque conservé)
RM peu serré	80 à 100	>2	<5
RM modéré	110 à 150	1.5 – 2	5 à 8
RM moyen	150 à 200	1.2 à 1.5	8 à 12
RM serré	>200	<1.2	>12

Table 9 Recommendations for classification of mitral stenosis severity

	Mild	Moderate	Severe
Specific findings			
Valve area (cm ²)	>1.5	1.0–1.5	<1.0
Supportive findings			
Mean gradient (mmHg) ^a	<5	5–10	>10
Pulmonary artery pressure (mmHg)	<30	30–50	>50

a : At heart rates between 60 and 80 bpm and in sinus rhythm.

Classification du rétrécissement mitral ; D'après Helmut Baumgartner, Page 17 [30].

TABLE 1. Grades of MS Severity

Severity	MVA, cm ²	Gradient, mm Hg	PAP	Symptoms	Signs	Therapy
Mild	>1.8	2–4	Normal	Usually absent	S ₂ -OS >120 ms; normal P ₂	IE prophylaxis
Moderate	1.2–1.6	4–9	Normal	Class II	S ₂ -OS 100–120 ms; normal P ₂	IE prophylaxis; diuretics
Moderate to severe	1.0–1.2	10–15	Mild pulmonary HTN	Class II–III	S ₂ -OS 80–100 ms; P ₂ increase	IE prophylaxis; BMV if applicable or surgery if more than mild Sx
Severe	<1.0	>15	Mild to severe pulmonary HTN	Class II–IV	S ₂ -OS <80 ms; P ₂ increase; RV lift Sx if R heart fails	IE prophylaxis; BMV or surgery

MVA indicates mitral valve area; PAP, pulmonary artery pressure; OS, opening snap; IE, infective endocarditis; HTN, hypertension; Sx, symptoms; and RV, right ventricular.

D'après Blase A. Carabello, Page 432-137 [31].

- L'échographie doppler trans-œsophagienne (ETO)

L'ETO permet de d'apprécier lésions anatomiques, d'apprécier les régurgitations mitrales, recherche la présence d'éventuel processus thrombotique (contraste ou thrombus).

Cathétérisme-angiographie:

L'exploration hémodynamique invasive pour l'exploration du RM n'est plus indispensable lorsqu'on dispose de résultats d'échographie Doppler fiables ; le cathétérisme permet de mesurer le gradient diastolique transmitral, d'estimer la surface mitrale, d'apprécier le niveau des pressions et des résistances vasculaires pulmonaires ;

La cinéangiographie ventriculaire gauche permet d'apprécier la cinétique de la valve mitrale (ouverture limitée en temps et fixée dans sa position d'ouverture) et les anomalies morphologiques de la valve et l'appareil sous valvulaire (stagnation du produit entre la valve postérieure et la paroi ventriculaire, images lacunaires intraventriculaires d'un pilier remaniée) ;

La coronarographie indiquée dans les formes avec angor, et au-delà de 40 ans chez l'homme et après la ménopause chez la femme.

EVOLUTION

Histoire naturelle

Le RM est une valvulopathie grave de pronostic spontanée sévère dès que le RM devient serré, selon Hortschotte, 15 ans après la poussée du RAA la moitié des patients sont asymptomatique, la classe III fonctionnelle est atteinte après 22 ans d'évolution, à noter que l'évolution est plus rapide dans les pays en voie de développement en raison du niveau socioéconomique [34].

L'évolution est marquée par la survenue de symptômes respiratoires (dyspnée d'effort, œdème pulmonaire, hémoptysie), de troubles du rythme (fibrillation auriculaire), des signes d'insuffisance cardiaque droite.

Complications évolutives :

- Troubles du rythme :

L'arythmie par fibrillation auriculaire marque l'évolution du RM, d'abord intermittente puis permanente, en rapport avec le diamètre de l'OG (ACFA présente 4/5 en cas d'OG >60 mm) ;

L'ACFA lorsqu'elle s'installe, elle aggrave les conditions hémodynamiques et réduit la tolérance fonctionnelle et majore le risque des complications thromboemboliques.

- Accidents pleuropulmonaires :

Plusieurs tableaux ; Dyspnée paroxystique (asthme cardiaque, œdème pulmonaire) est déclenchée par l'effort, l'émotion, la fièvre, la grossesse, fibrillation auriculaire, surcharge liquidienne ; Dyspnée permanente avec orthopnée (œdème alvéolaire interstitielle) ; les épanchements pleuraux sont en rapport avec une hyperpression veinocapillaire pulmonaire ou d'une embolie pulmonaire sous-corticale ; Les hémoptysies manifestation d'un infarctus pulmonaire ou d'œdème pulmonaire.

- Insuffisance cardiaque droite :

Elle couronne l'évolution des RM serrés non opérés, souvent déclenchée par la fibrillation auriculaire ou une embolie pulmonaire, elle peut associer une ascite, splénomégalie ou subictère en rapport avec fibrose hépatique (foie cardiaque).

- Complications thromboemboliques systémiques

Les embolies systémiques se voit chez 10 à 20 % des patients porteurs d'un RM, secondaire à la migration d'un thrombus au de l'auricule gauche ou rarement de l'oreillette gauche, les facteurs favorisants sont l'âge du patient, la fibrillation auriculaire ;

Les territoires atteints sont cerveau (territoire de la sylvienne gauche), membres, viscères ;

Quant à la thrombose massive de l'oreillette gauche, elle est rare, le tableau clinique est celui d'un RM très serré avec hypertension pulmonaire, bas débit, cyanose, le diagnostic est fait à l'échographie.

- Complications infectieuses

L'endocardite est rare dans le RM pure, évoquée devant une fièvre inexplicée et persistante, nécessite la pratique d'hémoculture et une échographie cardiaque (ETT/ETO).

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Certaines pathologies peuvent se présenter sous le tableau d'un rétrécissement mitral :

- Tumeur de l'OG (myxome), l'échographie trans thoracique et transoesophagienne oriente et confirmer le diagnostic
- Cardiothyroïse avec éclat de B1 associée à des troubles du rythme auriculaires
- Communication interauriculaire avec la possibilité d'un RM associé
- Péricardite constrictive (cavités gauches)

FORMES CLINIQUES

- Rétrécissement mitral œdémateux (forme de Gallavardin)

Cette forme s'observe chez la jeune femme, en rythme sinusal, sans cardiomégalie et sans dilatation de l'oreillette gauche, il s'agit de sténoses mitrales pures serrées avec hyperpression capillaire et résistances vasculaires normales ;

Cliniquement, les signes révélateurs sont une toux d'effort ou des accès régressifs d'œdème pulmonaire.

- RM avec hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)

Cette forme associée un RM et des résistances vasculaires pulmonaires induisant un barrage artériolaire précapillaire et une élévation de la pression artérielle pulmonaire (PAP moyenne < 40 mm Hg) ;

Dyspnée d'effort, cyanose et parfois, angor fonctionnel sont les symptômes cliniques fonctionnels, l'auscultation cardiaque, s'associé les signes du RM avec les signes d'HTAP (éclat de B2, IT et IP) ;

A l'ECG (signes de surcharge ventriculaire droite), au téléthorax, dilatation des artères pulmonaires proximales ;

Après la levée du barrage mitrale, les pressions capillaires chutent et les résistances et la pression artérielle pulmonaires s'abaissent lentement.

- RM de l'enfant

Cette forme survient avec dans les pays du tiers monde, elle est caractérisée par une symptomatologie fonctionnelle sévère (œdème pulmonaire, hémoptysie, HTAP élevée) ;

- RM du sujet âgé

Il s'agit soit d'un RM post rhumatismal ou de calcifications dégénérative de l'anneau mitral ;

- RM et grossesse

La grossesse induit des modifications hémodynamiques (augmentation de la volémie et du débit cardiaque) surtout pendant le 3^{ème} trimestre et au cours du travail, responsable de la survenue de certaines complications (OAP, hémoptysie) ;

En cas de mauvaise tolérance et de répétition des accidents gravidocardiaques, un geste valvulaire est recommandé.

- RM est coronaropathie

L'association d'une lésions coronaire et d'un RM n'est pas négligée, d'où l'intérêt d'une coronarographie en préopératoire en cas de symptomatologie fonctionnelle angineuse ou au-delà de 35 ans chez l'homme et chez la femme ménopausée.

- Maladie mitrale

L'association d'une sténose assez serrée ou serrée à une fuite significative d'origine rhumatismale est qualifiée de maladie mitrale (MM);

Sur le plan physiopathologique, la MM à double conséquences, une surcharge volumétrique du ventricule gauche et des perturbations hémodynamiques en amont de la valve mitrale ;

Sur le plan clinique, la symptomatologie est plus précoce, l'échographie cardiaque Doppler pose le diagnostic et apprécie le retentissement.

- RM et valvulopathies associés

On décrit des associations lésionnelles valvulaires (RM et insuffisance aortique, RM et rétrécissement aortique, RM et insuffisance tricuspide, RM et rétrécissement tricuspide) et des lésions associées (Sd de Lutembacher : RM et communication interauriculaire congénitale) ainsi que les communications interauriculaires post dilatation mitral par voie trans-septale.

TRAITEMENT

On dispose pour le traitement du RM de différents moyens :

- Traitement médical :

Il est indiqué en cas de : OAP, insuffisance cardiaque, embolies, fibrillation auriculaire, prophylaxie anti-infectieuse.

- Dilatation percutanée :

La première dilatation pratiquée par K Inoue en 1984, cette technique a vu son indication s'élargir en matière du RM pur, elle consiste en l'ouverture des commissures symphysées par l'introduction d'un ballonnet au niveau de l'orifice mitral, par voie transseptale (voie transveineuse antérograde) ou par voie rétrograde combinée ou non à la voie transseptale, deux types de ballons, à double ballon ou à ballon d'Inoue (le plus utilisé) ;

La procédure est arrêtée en cas : une surface supérieure à 1 cm²/m², ouverture complète d'au moins une commissure, apparition ou majoration de la régurgitation mitrale supérieure au grade II.

- Chirurgie :

Commissurotomie à cœur fermé :

Elle consiste en l'ouverture des commissures symphysées par le doigt ou souvent un dilateur introduits par voie de l'auricule gauche rarement par voie transventriculaire gauche.

Commissurotomie à cœur ouvert :

Elle consiste en l'ouverture des commissures symphysées sous contrôle de la vue sous CEC.

Remplacement valvulaire :

Le remplacement valvulaire consiste en l'exérèse d'une valve mitrale dont les lésions anatomiques sont incompatibles avec un geste conservateur, ainsi en cas d'échec d'un traitement conservateur, divers substituts valvulaires, biologique ou mécanique.

Indications :

Les progrès techniques en matière de la cardiologie interventionnelle ont élargi l'indication de dilatation percutanée en matière du RM pur à valves et appareil sous valvulaire souples, la chirurgie est indiquée d'emblée en cas de RM avec calcifications bicommissurales, régurgitation significative ou thrombus intra-auriculaire.

Selon les recommandations de la Société française de cardiologie concernant la prise en charge des valvulopathies acquises et des dysfonctions de prothèse valvulaire [27]:

Rétrécissement mitral : contre indication à la commissurotomie mitrale percutanée :

- Thrombose intracardiaque
- Insuffisance mitrale > 2/4
- Calcifications valvulaires importantes et/ou bicommissurales
- Valvulopathie(s) associée(s) nécessitant une correction chirurgicale
- Coronaropathie sévère nécessitant un pontage coronaire.

Indications d'intervention dans le rétrécissement mitral serré (Surface mitrale < 0,9 cm²/m²) [27]:

Patients asymptomatiques

Indications admises pour la CMP (si anatomie valvulaire et contexte clinique favorables)

- risque thromboembolique élevé : antécédent embolique, contraste spontané intra-auriculaire gauche intense, ou trouble du rythme supra-ventriculaire paroxystique ou permanent
- risque de décompensation hémodynamique : HTAP (pression artérielle pulmonaire systolique > 50 mm Hg au repos), désir de grossesse, nécessité de chirurgie extracardiaque programmée à risque intermédiaire ou élevé.

Indications discutées pour la CMP (si anatomie valvulaire et contexte clinique favorables)

- RM serré en rythme sinusal avec dilatation importante de l'oreillette gauche (diamètre > 50 mm)
- RM serré avec pression artérielle pulmonaire systolique à l'effort > 60 mm Hg.

Patients symptomatiques

Indication formelle

- RM serré ; l'indication est formelle et les discussions ne concernent que la technique d'intervention
- CMP en première intention, sauf contre indication à la CMP et sauf sujets âgés avec anatomie valvulaire défavorable et sans contre-indication à la chirurgie
- chirurgie si contre-indication à la CMP ou sujet âgé avec anatomie valvulaire défavorable pour la CMP
- CMP en cas de resténose serrée après commissurotomie chirurgicale ou percutanée si anatomie valvulaire et contexte clinique favorables.

Indication opératoire d'une sténose mitrale d'après Alec Vahanian et al. Page 249 [139].